



Douleurs de plusieurs articulations

Par [Alexandra Villa-Forte](#), MD, MPH, Cleveland Clinic

Reviewed By [Brian F. Mandell](#), MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

Vérifié/Révisé avr. 2025

Les articulations peuvent être simplement douloureuses (arthralgies) ou encore inflammées (arthrites). L'inflammation des articulations est généralement accompagnée d'une chaleur, d'un gonflement (dû à l'épanchement intra-articulaire) et plus rarement d'un érythème. La douleur peut ne survenir que lors de l'utilisation ou même au repos. Parfois, ce qui est décrit par les patients comme des douleurs articulaires peut être d'origine extra-articulaire (p. ex., une structure périarticulaire ou osseuse).

La douleur polyarticulaire (polyarthralgie) implique plusieurs articulations (voir aussi [douleur d'une seule articulation](#)). Les troubles polyarticulaires peuvent affecter différentes articulations à différents moments. Lorsque plusieurs articulations sont touchées, la distinction suivante peut être utile dans la différenciation entre les différents troubles, notamment les arthrites:

- Oligoarticulaire: atteinte de ≤ 4 articulations
- Polyarticulaire: implique > 4 articulations

Physiopathologie de la douleur de plusieurs articulations

Les sources de douleurs articulaires proviennent de l'intérieur de l'articulation. Les causes de douleurs périarticulaires proviennent des structures qui entourent l'articulation (p. ex., tendons, ligaments, bourses, muscles).

Une douleur polyarticulaire provoquée par des sources articulaires peut résulter de:

- Inflammation (p. ex., infection, [arthrite induite par des cristaux](#), troubles inflammatoires systémiques comme la [polyarthrite rhumatoïde](#) et l'[arthrite psoriasique](#))
- Affections non inflammatoires mécaniques ou autres (p. ex., [arthrose](#), syndromes d'hypermobilité)

La membrane synoviale et la capsule articulaire sont les principales sources de douleur d'une articulation. La membrane synoviale est le principal site touché par l'inflammation (synovite). Des douleurs affectant plusieurs articulations en l'absence d'inflammation peuvent être dues à une augmentation de la laxité articulaire et à des traumatismes excessifs, comme dans le syndrome d'hypermobilité bénigne.

La polyarthrite peut impliquer des articulations périphériques et/ou axiales (p. ex., sacro-iliaques, interapophysaires postérieures, discovertébrales, costovertébrales).

Étiologie de la douleur de plusieurs articulations

L'arthrite oligoarticulaire périphérique et l'arthrite polyarticulaire sont plus souvent associées à une infection systémique (p. ex., virale) ou à un trouble inflammatoire systémique (p. ex., [polyarthrite rhumatoïde](#)) que ne le sont les mono-arthrites. Une cause spécifique peut généralement être déterminée (voir tableaux [Certaines causes de douleur dans ≥ 5 articulations](#) et [Certaines causes de douleur dans ≤ 4 articulations](#)); cependant, parfois l'arthrite est transitoire et disparaît avant qu'un diagnostic puisse être clairement établi. Une atteinte axiale suggère une [spondylarthropathie séronégative](#) (également appelée spondyloarthritis), mais peut également se produire dans la polyarthrite rhumatoïde (affectant le rachis cervical, mais pas la colonne lombaire).

Une polyarthrite aiguë est le plus souvent secondaire aux causes suivantes:

- Une infection (habituellement virale)
- Exacerbation d'un trouble inflammatoire systémique
- [Goutte](#) ou l'[arthrite à cristaux de pyrophosphate de calcium](#) (précédemment appelée pseudogout)

Les polyarthrites chroniques de l'adulte sont le plus souvent dues aux causes suivantes:

- [Polyarthrite rhumatoïde](#)
- [Spondyloarthropathie séronégative](#) (généralement [spondylarthrite ankylosante](#), [arthrite réactionnelle](#), [rhumatisme psoriasique](#) ou arthrite associée aux [maladies inflammatoires de l'intestin](#))

La douleur polyarticulaire non inflammatoire de l'adulte est le plus souvent due aux causes suivantes:

- [Arthrose](#)

Les polyarthrites chroniques chez l'enfant sont le plus souvent dues aux causes suivantes:

- [Arthrite juvénile idiopathique](#)

TABLEAU

Certaines causes de douleurs dans ≥ 5 articulations*

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic†
Rhumatisme articulaire aigu	Douleur migratoire qui touche principalement les grosses articulations des jambes, les coudes et les poignets	Critères cliniques spécifiques (de Jones) Tests pour le streptocoque du groupe A (p. ex., culture, test

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic†
	Douleur plus sévère que l'œdème Manifestations extra-articulaires, telles que la fièvre, la symptomatologie de dysfonction cardiaque, la chorée, les nodules sous-cutanés et l'éruption cutanée Antécédent d'angine streptococcique	streptococcique rapide, titres d'antistreptolysine O et d'anti-DNase B) ECG et échocardiogramme
Hémoglobinopathies (p. ex., drépanocytose homozygote ou hétérozygote, thalassémies)	Douleur habituellement proche, mais parfois interne, aux articulations, parfois symétrique Généralement les patients enfants ou jeunes d'origine africaine ou méditerranéenne, avec un diagnostic souvent déjà connu	Électrophorèse de l'hémoglobine
Syndromes d'hypermobilité (p. ex., d'Ehlers-Danlos, Marfan, hypermobilité bénigne)	Polyarthralgie, rarement avec arthrite Subluxation récurrente de l'articulation Parfois, laxité cutanée augmentée Généralement antécédents familiaux d'hypermobilité articulaire Pour les syndromes de Marfan et d'Ehlers-Danlos, il peut y avoir des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection à un jeune âge ou à l'âge moyen	L'anamnèse et l'examen clinique Parfois, des tests génétiques (aucun test génétique n'est disponible pour l'Ehlers-Danlos hypermobile)

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic†
L' arthrite bactérienne infectieuse (septique) (plus fréquemment monoarticulaire)	Arthrite aiguë avec douleur intense et épanchements articulaires Parfois, immunosuppression ou facteurs de risque pour les infections sexuellement transmissibles	Arthrocentèse
Arthrite infectieuse virale (parvovirus B19 , hépatite B , hépatite C , entérovirus , rubéole , oreillons et VIH)	Arthrite aiguë Douleur et augmentation de volume articulaires généralement moins sévères que dans l'arthrite infectieuse bactérienne D'autres symptômes systémiques fonction du virus (p. ex., ictère dans l'hépatite B, souvent lymphadénopathie généralisée avec le VIH)	Sérologie virale selon les indications cliniques (p. ex., antigène de surface de l'hépatite B et anticorps IgM contre l'antigène core de l'hépatite B en cas de suspicion d'hépatite B)
Arthrite juvénile idiopathique	Apparition au cours de l'enfance de symptômes articulaires Manifestation d'oligoarthrite plus uvéite, ou de symptômes systémiques (maladie de Still, fièvre, éruption cutanée, adénopathie, splénomégalie, et/ou épanchements pleuraux et péricardiques)	L'anamnèse et l'examen clinique Anticorps antinucléaires, facteur rhumatoïde et recherche du HLA-B27
D'autres maladies rhumatismales systémiques (p. ex., syndrome de Sjögren , myopathie inflammatoire , pseudo-polyarthrite)	Manifestations spécifiques de la maladie, y compris les manifestations dermatologiques (dermatomyosite), la dysphagie, un syndrome	L'anamnèse et l'examen clinique Parfois, des radiographies et/ou examens sérologiques (p. ex., anti-Ro/SSA et anti-La/SSB dans

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic†
<u>rhizomélisque</u> , <u>sclérose systémique</u>)	de Raynaud ou une sclérodactylie sévère (sclérodermie), les douleurs musculaires (pseudo-polyarthrite rhizomélisque) ou les yeux et bouche secs (syndrome de Sjögren)	le syndrome de Sjögren, anti-Scl-70 dans la sclérodermie systémique) Parfois, biopsie cutanée ou biopsie musculaire
<u>Arthrite psoriasique</u>	L'un des cinq modes d'atteinte articulaire, qui comprend une polyarthrite similaire à la polyarthrite rhumatoïde et l'oligoarthrite Manifestations extra-articulaires, tels que psoriasis, onychodystrophie, uvéite, tendinites, et dactylite (doigt "en saucisse")	L'anamnèse et l'examen clinique Radiographies
<u>Polyarthrite rhumatoïde</u>	Arthrite symétrique des petites et grandes articulations Rarement, initialement monoarticulaire ou oligoarticulaire Elle est plus fréquente chez les jeunes adultes, mais peut survenir à tout âge Parfois, des déformations articulaires à des stades tardifs	L'anamnèse et l'examen clinique Facteur rhumatoïde et test des anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (CCP) Radiographies
Maladie sérique	Arthralgie plus souvent qu'arthrite Fièvre, lymphadénopathie et éruption cutanée	L'anamnèse et l'examen clinique

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic†
	Exposition à des produits sanguins dans les 21 jours de l'apparition des symptômes	
<u>Lupus érythémateux disséminé</u>	Arthralgie plus souvent qu'arthrite Arthropathie de Jaccoud Manifestations systémiques, comme une éruption cutanée (p. ex., éruption malaire), lésions muqueuses (p. ex., ulcères buccaux), sérite (p. ex., pleurésie, péricardite), manifestations de glomérulonéphrite Plus fréquente chez la femme	L'anamnèse et l'examen clinique Anticorps antinucléaires, anti-dsDNA, numération formule sanguine (leucopénie ou thrombopénie), analyse d'urine, profil chimique de la créatinine et des enzymes hépatiques
Vascularites systémiques (p. ex., <u>vascularite à immunoglobulines A</u> [anciennement appelée purpura de Henoch-Schönlein ou rhumatoïde], <u>polyartérite noueuse</u> , <u>granulomatose avec polyangéite</u> [anciennement appelée granulomatose de Wegener])	Arthralgie plus souvent qu'arthrite Les symptômes extra-articulaires, impliquant souvent plusieurs systèmes d'organes (p. ex., des douleurs abdominales, une insuffisance rénale, les manifestations d'une pneumonie, des symptômes nasosinusiens, des lésions cutanées qui peuvent comprendre des éruptions cutanées, un purpura, des nodules, et des ulcères)	Les tests sérologiques indiqués cliniquement (p. ex., les tests ANCA (antineutrophil cytoplasmic autoantibodies) pour une suspicion de granulomatose avec polyangéite [anciennement appelée granulomatose de Wegener]) Biopsie selon les indications (p. ex., des reins, de la peau ou du poumon)

*Ces pathologies peuvent également se manifester sous une forme oligoarticulaire (impliquant ≤ 4 articulations).

†Les patients qui présentent des épanchements ou une inflammation articulaires aigus doivent subir une ponction articulaire (avec numération cellulaire, coloration de Gram, cultures et recherche de cristaux) et habituellement la vitesse de sédimentation érythrocytaire (VS) et la protéine C réactive (CRP). Les radiographies sont souvent inutiles.

dsDNA = ADN double brin.

TABLEAU

Certaines causes de douleurs dans ≤ 4 articulations

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic*
<u>Spondylarthrite ankylosante</u> †	Habituellement douleur et raideur axiales, plus importantes le matin et soulagées par une activité Parfois épanchements dans les grandes articulations périphériques Parfois manifestations extra-articulaires (p. ex., uvéite, enthésopathie, insuffisance aortique) Plus fréquente chez les jeunes hommes adultes	Radiographie de la colonne lombo-sacrée Parfois IRM ou TDM, examens sanguins (vitesse de sédimentation érythrocytaire, protéine C réactive et NFS) et/ou des critères cliniques spécifiques (critères modifiés de New York)
<u>Syndrome de Behçet</u>	Arthralgie ou arthrite Manifestations extra-articulaires telles que les lésions buccales et/ou génitales récurrentes, ou uvéite Début habituellement entre 20 et 30 ans	Critères cliniques spécifiques (internationaux)

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic*
L'arthrite microcristalline†, généralement causée par des cristaux d'acide urique (goutte), par des cristaux de pyrophosphate de calcium dihydraté (arthrite à cristaux de pyrophosphate de calcium) ou d'hydroxyapatite de calcium	Apparition soudaine d'une arthrite avec chaleur et gonflements articulaires Peut être cliniquement indiscernable d'une arthrite infectieuse bactérienne (septique) Parfois, de la fièvre	Arthrocentèse
Endocardite infectieuse	Arthralgie ou arthrite Symptômes systémiques, tels que fièvre, sueurs nocturnes, éruption cutanée, perte de poids, souffle cardiaque	Hémocultures Échocardiographie
Arthrose †	La douleur chronique affecte le plus souvent la base des pouces, les articulations interphalangiennes proximales et distales, les genoux et les hanches Parfois nodosités d'Heberden et/ou de Bouchard	Radiographies
Arthrite réactive et arthrite liée aux maladies inflammatoires de l'intestin†	Arthrite asymétrique et plus fréquente au niveau des grandes articulations des membres inférieurs Arthrite réactive: infection digestive ou génito-urinaire présente 1-3 semaines avant l'apparition de l'arthrite aiguë	L'anamnèse et l'examen clinique Recherche d'infections sexuellement transmissibles selon les indications cliniques

Cause	Signes évocateurs	Diagnostic*
	Arthrite liée aux maladies inflammatoires de l'intestin: présence d'une pathologie gastro-intestinale coexistante (p. ex., maladie inflammatoire de l'intestin, chirurgie de dérivation intestinale) avec une arthrite chronique	
* Les patients qui présentent un épanchement articulaire aigu avec inflammation doivent subir une ponction articulaire (avec numération cellulaire, coloration de Gram, cultures et recherche de cristaux) et habituellement la vitesse de sédimentation érythrocytaire (VS) et la protéine C réactive (CRP). Souvent, les radiographies ne sont pas utiles au début de l'évolution de la maladie. †Ces pathologies peuvent se manifester par une atteinte axiale. ‡L'arthrite microcristalline est le plus souvent monoarticulaire mais peut parfois être oligo- ou poly-articulaire.		

Évaluation de la douleur de plusieurs articulations

Le bilan doit déterminer si les articulations et/ou les structures périarticulaires sont la cause des symptômes et s'il existe une inflammation. Une symptomatologie extra-articulaire qui peut faire évoquer des troubles inflammatoires systémiques spécifiques, doit également être recherchée et évaluée, en particulier en cas d'inflammation des articulations.

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit identifier les caractéristiques d'une douleur articulaire, associée à des symptômes articulaires et des symptômes systémiques. Parmi les caractéristiques importantes des symptômes articulaires, sont importants le caractère aigu de l'apparition de la maladie (p. ex., brutalement, progressivement), l'évolution temporelle (p. ex., variation diurne, persistance versus intermittence), la durée (p. ex., aiguë versus chronique) et les facteurs aggravants et d'amélioration (p. ex., repos, activité) Les patients doivent être interrogés spécifiquement sur leurs relations sexuelles non protégées (indiquant un risque d'arthrite bactérienne infectieuse avec infection

gonococcique disséminée) et sur des morsures de tique ou de séjours dans une région où la maladie de Lyme est endémique.

Revue des systèmes doit être complet afin d'identifier les symptômes extra-articulaires qui peuvent suggérer des troubles spécifiques (voir tableaux [Certaines causes de douleur dans \$\geq 5\$ articulations](#), [Certaines causes de douleur dans \$\leq 4\$ articulations](#), et [Signes évocateurs dans les douleurs polyarticulaires](#)).

Antécédents médicaux et les antécédents familiaux doivent identifier les troubles inflammatoires systémiques connus et d'autres pathologies susceptibles de provoquer des symptômes articulaires (voir tableaux [Certaines causes de douleur dans \$\geq 5\$ articulations](#) et [Certaines causes de douleur dans \$\leq 4\$ articulations](#)). Certains troubles inflammatoires systémiques sont plus prévalents dans les familles qui ont des profils génétiques spécifiques.

Examen clinique

L'examen clinique doit être raisonnablement complet, et évaluer tous les principaux systèmes d'organes (p. ex., peau et ongles, yeux, organes génitaux, muqueuses, cœur, poumons, abdomen, nez, cou, ganglions lymphatiques et système neurologique) ainsi que le système musculo-squelettique. Les signes vitaux sont recherchés, notamment la fièvre.

L'examen de la tête doit rechercher des signes d'inflammation oculaire (p. ex., uvéite, conjonctivite) et des lésions nasales ou orales. La peau doit être inspectée à la recherche d'éruptions et de lésions (p. ex., ecchymoses, ulcères, plaques psoriasiques, purpura, éruption malaire). Le patient est également évalué à la recherche d'une lymphadénopathie et d'une splénomégalie.

L'examen cardio-pulmonaire doit noter tous les signes de pleurésie, de péricardite ou d'anomalies des valvules (p. ex., souffle, frottement péricardique, bruits cardiaques étouffés, matité des bases compatibles avec un épanchement pleural bilatéral).

L'examen génital doit rechercher tout écoulement, ulcère ou autres signes compatibles avec une infection sexuellement transmissible.

L'examen de l'appareil musculosquelettique doit commencer par distinguer le tissu articulaire du tissu péri-articulaire ou d'un autre tissu conjonctif ou de la douleur musculaire. L'examen articulaire commence par une inspection à la recherche de déformations, d'un érythème, de gonflements ou d'épanchement, et se poursuit avec la palpation et la recherche d'épanchements, de chaleur et de points douloureux au niveau des articulations. La mobilité active et passive doit être évaluée. Des crépitements peuvent être ressentis lors de la flexion et/ou de l'extension de l'articulation. La comparaison avec l'articulation controlatérale non pathologique est souvent utile pour détecter des signes plus discrets. L'examen doit noter si la distribution des atteintes articulaires est symétrique ou asymétrique. Les articulations douloureuses peuvent également être compressées sans les fléchir ou les étendre.

Les structures périarticulaires doivent également être examinées pour savoir si les tendons, les bourses ou les ligaments sont atteints, à la recherche d'œdèmes mous au niveau d'une bourse séreuse (bursite) ou d'une douleur au niveau de l'insertion d'un tendon (tendinite).

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Chaleur, augmentation de volume, douleur et érythème articulaire
- Tout symptôme extra-articulaire (p. ex., fièvre, frissons, éruption cutanée, plaques cutanées ou petits trous sur la surface des ongles, ulcères muqueux, conjonctivite, uvéite, souffle cardiaque, purpura, perte de poids)

Interprétation des signes

Un élément important initial à déterminer en se basant principalement sur un examen clinique attentif est de savoir si les douleurs proviennent des articulations, d'autres structures adjacentes (p. ex., os, tendons, bourses séreuses, muscles), ou des deux (p. ex., comme dans la goutte) ou d'autres structures. Une douleur ou une tuméfaction d'un seul côté d'une articulation ou à distance de l'interligne articulaire suggèrent une origine extra-articulaire (p. ex., tendons ou bourses); une douleur localisée sur l'interligne articulaire ou une atteinte de l'articulation plus diffuse évoquent une cause intra-articulaire. Comprimer l'articulation sans flexion ni extension, n'est pas particulièrement douloureux en cas de [tendinite](#) ou de [bursite](#), mais est très douloureux en cas d'arthrite. Une douleur qui s'aggrave lors de la mobilisation active et non passive des articulations peut être révélatrice d'une tendinite ou d'une bursite (extra-articulaire); l'inflammation intra-articulaire limite généralement les mouvements actifs et passifs de façon très importante.

Une autre décision importante est de savoir si les articulations sont enflammées. Une douleur au repos et au début d'une activité suggère une inflammation articulaire, alors qu'une douleur exacerbée par le mouvement et soulagée par le repos suggère des troubles d'origine mécanique ou non inflammatoires (p. ex., une [arthrose](#)). L'augmentation de la chaleur et un érythème suggèrent également une inflammation, mais ces signes sont souvent peu sensibles, et leur absence n'exclut donc pas une inflammation.

Une raideur matinale prolongée, une raideur après une inactivité prolongée (phénomène de gel), un gonflement articulaire non traumatique, et une fièvre ou une perte de poids non intentionnelle sont évocateurs d'une affection inflammatoire systémique touchant les articulations. Une douleur qui est diffuse, décrite vaguement et qui affecte les structures myofasciales sans signe d'inflammation suggère une [fibromyalgie](#).

Le type d'atteinte articulaire permet d'établir un diagnostic. La symétrie des atteintes articulaires peut aussi être un indice. L'atteinte tend à être symétrique dans la [polyarthrite rhumatoïde](#), tandis qu'une atteinte asymétrique est plus évocatrice de [rhumatisme psoriasique](#), de [goutte](#) et d'[arthrite réactionnelle](#) ou d'arthrite liée aux maladies inflammatoires intestinales.

L'examen des articulations de la main peut donner d'autres indices (voir tableau [Signes évocateurs dans les douleurs polyarticulaires](#)) qui permettent de différencier l'arthrose de la polyarthrite rhumatoïde (voir tableau [Caractéristiques différentielles de la main dans la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose](#)) ou qui peuvent suggérer d'autres troubles.

Une douleur rachidienne en présence d'une arthrite périphérique évoque une [spondyloarthropathie séronégative](#) ([spondylarthrite ankylosante](#), [arthrite réactionnelle](#), [rhumatisme psoriasique](#) ou arthrite liée aux maladies inflammatoires de l'intestin), mais peut survenir dans la [polyarthrite rhumatoïde](#) (généralement avec douleur rachidienne cervicale). L'apparition d'une oligoarthrite, avec une douleur rachidienne est particulièrement susceptible de correspondre à une spondylarthropathie séronégative si le patient a des antécédents familiaux de cette maladie. Une rougeur des yeux et des lombalgies évoquent une spondylarthrite ankylosante. Un antécédent de psoriasis en plaques chez un patient chez qui apparaît une nouvelle oligoarthrite est fortement en faveur d'une arthrite psoriasique.

TABLEAU

Signes évocateurs dans les douleurs polyarticulaires

Signes	Cause possible
Signes généraux	
Tendinite coexistante	Polyarthrite rhumatoïde , infection gonococcique disséminée , arthrite psoriasique , goutte , arthrite juvénile idiopathique (lorsqu'elle débute à l'âge de ≤ 16 ans)
Conjonctivite, diarrhées, lésions cutanées et génitales	Arthrites réactionnelles
Fièvre	Arthrite infectieuse , goutte , troubles inflammatoires systémiques (p. ex., lupus érythémateux disséminé , polyarthrite rhumatoïde)
Malaise, perte de poids et adénopathie	Infection aiguë par le VIH , arthrite juvénile idiopathique (maladie de Still)
Lésions orales et génitales	Maladie de Behçet , arthrites réactionnelles
Plaques argentées surélevées	Rhumatisme psoriasique
Pharyngite récente et arthrite migratrice ou arthralgie grave	Rhumatisme articulaire aigu , infection gonococcique disséminée
Vaccination récente ou utilisation d'un produit sanguin	Maladie sérique
Lésions cutanées, douleurs abdominales, symptômes respiratoires et lésions muqueuses	Vascularite systémique

Signes	Cause possible
Urétrite	Arthrite réactive ou infection gonococcique disséminée
Signes au niveau de la main	
Atteinte asymétrique des articulations interphalangiennes distales et proximales avec gonflement diffus des doigts (dactylite) et/ou petits trous sur la surface des ongles	Rhumatisme psoriasique
Nodules (tophi) plus atteinte asymétrique de toutes les articulations de la main, y compris une inflammation aiguë des articulations interphalangiennes distales (nodosités d'Heberden)	Goutte
Augmentation du volume osseux des articulations interphalangiennes distales (nodosités de Bouchard) ou proximales (nodosités d'Heberden)	Arthrose
Atteinte du premier carpométacarpien	
Phénomène de Raynaud	Sclérodermie , lupus érythémateux disséminé ou connectivite mixte
Desquamation et éruption cutanée, souvent avec formation de plaques, sur les surfaces d'extension des articulations métacarpophalangiennes et des articulations interphalangiennes proximales (papules de Gottron)	Dermatomyosite
Laxité de plusieurs tendons des doigts pouvant entraîner des déformations des doigts réductibles (arthropathie de Jaccoud)	Lupus érythémateux disséminé
Atteinte symétrique des articulations interphalangiennes proximales et des articulations métacarpophalangiennes, en particulier avec déformations en col-de-cygne ou en boutonnière	Polyarthrite rhumatoïde

Signes	Cause possible
Épaississement de la peau au-dessus des doigts (sclérodactylie) et rétractions en flexion	Sclérodermie

TABLEAU

Caractéristiques différentielles de la main dans la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose

Critères	Polyarthrite rhumatoïde	Arthrose
Gonflement des articulations	Fréquent Tissus mous synoviaux, capsulaires	Rare Peut-être un léger gonflement
Hypertrophie osseuse	Seulement aux stades tardifs	Fréquent, souvent avec des épines irrégulières
Implication des interphalangiennes distales	Rare	Fréquentes
Atteinte des articulations métacarpophalangiennes	Fréquentes	Insolite, habituellement modérée Peut-être atteinte significative de l'articulation métacarpophalangienne dans l'hémochromatose
Atteinte des articulations interphalangiennes proximales	Fréquentes	Fréquentes
Atteinte du poignet	Fréquentes	Rare, mais l'atteinte de la première articulation carpométacarpienne (fréquente) est parfois perçue comme une douleur du poignet

Critères	Polyarthrite rhumatoïde	Arthrose
		Absence de gonflement du poignet
Adapted from Bilka PJ: Physical examination of the arthritic patient. <i>Bulletin on the Rheumatic Diseases</i> 20:596-599, 1970.		

Examens complémentaires

Les examens suivants sont d'une importance particulière:

- Arthrocentèse
- Habituellement, vitesse de sédimentation érythrocytaire (VS) et protéine C réactive (CRP)
- Tests sérologiques
- Dans l'arthrite chronique, les radiographies et/ou l'échographie

L'arthrocentèse est indispensable chez la plupart des patients en cas de nouvel épanchement pour éliminer une infection et identifier les cristaux (voir [Comment effectuer une arthrocentèse](#)). Il peut également permettre de distinguer entre un processus inflammatoire et non inflammatoire. L'examen du liquide synovial comprend une numération leucocytaire avec formule, une coloration de Gram et des cultures, et l'examen microscopique à la recherche de cristaux en lumière polarisée. Trouver des cristaux dans le liquide synovial confirme l'origine microcristalline de l'arthrite mais n'exclut pas la coexistence d'une infection. Un liquide synovial non inflammatoire (p. ex., numération leucocytaire $< 1000/\text{mCL}$ [$< 1 \times 10^9/\text{L}$]) est plus évocateur d'une arthrose ou d'un traumatisme. Un liquide hémorragique est compatible avec une hémarthrose. La numération leucocytaire du liquide synovial peut être très élevée (p. ex., $> 50\,000/\text{mCL}$ [$> 50 \times 10^9/\text{L}$]) dans l'arthrite infectieuse et dans celle induite par des cristaux. La numération leucocytaire du liquide synovial dans les troubles inflammatoires systémiques causes de polyarthrite se situe le plus souvent entre environ 1000 et 50 000/mcL (1 et $50 \times 10^9/\text{L}$).

Si le diagnostic spécifique ne peut être établi par l'anamnèse et l'examen, des examens complémentaires peuvent être nécessaires. La VS et la protéine C réactive peuvent être mesurées pour déterminer si l'arthrite est inflammatoire. Des valeurs élevées de protéine C réactive et une VS élevée sont en faveur d'une inflammation mais ne sont pas spécifiques, en particulier chez l'adulte plus âgé. Les signes sont plus spécifiques si les valeurs sont élevées lors des exacerbations de la maladie inflammatoire mais normales pendant les périodes de quiescence de la maladie.

Lorsque le diagnostic de trouble inflammatoire systémique est cliniquement suspecté, des tests sérologiques de confirmation comprenant le dosage des anticorps antinucléaires, de l'ADN double brin, du facteur rhumatoïde, de l'anticorps des peptides anticycliques citrullinés et des anticorps anti-cytoplasme de neutrophiles peuvent permettre de poser le diagnostic. Des tests spécifiques *ne doivent*

être demandés qu'en soutien d'un diagnostic spécifique, comme le lupus érythémateux disséminé, la vascularite associée aux ANCA ou la polyarthrite rhumatoïde.

Si l'arthrite est chronique, des radiographies et/ou une échographie sont généralement effectuées pour rechercher des signes de lésions articulaires (p. ex., érosions dans la polyarthrite rhumatoïde).

L'échographie articulaire présente de nombreux avantages par rapport aux radiographies, notamment en permettant une meilleure identification du liquide autour des articulations, la visualisation des tendons et d'autres structures périarticulaires lors de l'examen physique, l'évaluation des signes d'inflammation active, l'identification des tophus ou des signes échographiques de dépôts cristallins, et en offrant un guidage pour l'arthrocentèse et les injections articulaires. L'IRM permet également de visualiser les structures péri-articulaires, d'évaluer les signes d'inflammation active et d'aider à identifier d'autres anomalies structurelles (p. ex. érosions articulaires).

D'autres tests peuvent être nécessaires pour identifier des troubles spécifiques (voir tableaux [Certaines causes de douleur dans ≥ 5 articulations](#) et [Certaines causes de douleur dans ≤ 4 articulations](#)).

Traitement de la douleur de plusieurs articulations

En cas de douleurs articulaires, le trouble sous-jacent est traité si possible.

Les maladies systémiques inflammatoires peuvent nécessiter soit une immunodépression soit des antibiotiques selon le diagnostic.

L'inflammation articulaire est habituellement traitée symptomatiquement par des AINS. La douleur non inflammatoire est habituellement traitée de façon plus sûre par du paracétamol.

Immobiliser l'articulation avec une attelle ou une écharpe peut parfois soulager la douleur. Le traitement par la chaleur ou la cryothérapie peuvent avoir un effet antalgique sur les inflammations articulaires. Comme la polyarthrite chronique peut conduire à l'inactivité et à une atrophie musculaire secondaire, une activité physique continue doit être encouragée.

Bases de gériatrie: douleur articulaire

L'[arthrose](#) est de loin la cause la plus fréquente d'arthrite chez les sujets âgés.

La [polyarthrite rhumatoïde](#) débute le plus souvent entre les âges de 30 et 40 ans, mais chez près d'1/3 des patients, elle se développe après l'âge de 60 ans.

Les cancers pouvant causer des polyarthrites paranéoplasiques, le cancer doit être évoqué chez les sujets âgés chez lesquels une polyarthrite rhumatoïde d'apparition récente est suspectée, en particulier si le début est aigu, si les membres inférieurs sont principalement touchés, ou en cas de douleurs osseuses.

Une [pseudo-polyarthrite rhizomélisque](#) doit également être évoquée chez les patients de > 50 ans qui ont une rigidité et une douleur de la hanche et de la ceinture scapulaire, même si les patients ont une

arthrite des articulations périphériques (le plus souvent des mains).

La goutte chez les femmes âgées a une prédilection pour les articulations interphalangiennes distales des mains, peut imiter l'arthrose « érosive » des mains et peut survenir sans antécédents d'exacerbations typiques de la goutte.

Points clés

- Le diagnostic différentiel des douleurs articulaires polyarticulaires peut être précisé en recherchant quelles articulations et combien sont atteintes, si l'inflammation est présente, si la distribution des articulations est symétrique, et si des symptômes ou signes extra-articulaires sont présents.
- La polyarthrite chronique est le plus souvent causée par l'arthrite juvénile idiopathique chez l'enfant, et la polyarthralgie chronique est le plus souvent causée par l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde chez l'adulte.
- L'arthrite polyarticulaire aiguë est le plus souvent due à une infection, à une goutte ou à une exacerbation d'une maladie rhumatismale systémique.
- L'arthrocentèse est impérative dans la plupart des cas d'épanchement d'apparition récente pour éliminer une infection, diagnostiquer une arthropathie induite par les cristaux, et elle peut permettre de faire la distinction entre un processus inflammatoire et un processus non inflammatoire.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.